

Najpierw umiejętności *potem narracja traumy*

STAIR (8 sesji) trenuje regulację afektu i kompetencje interpersonalne. NST (8 sesji) — stopniowe przetwarzanie narracyjne. Najlepiej zewalutowany protokół Fazy 1.

CZAS: 8–16 sesji (8 STAIR + 8 NST opcjonalnie) **REALIZACJA:** Faza 1 lub przejście Faza 1 → Faza 2

ŹRÓDŁO: Cloitre, Cohen & Koenen (2006, 2010, manual STAIR); Cloitre i in. (2012, RCT, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*: STAIR+NST $d = 1,05$ kontra PE samodzielnie $d = 0,82$)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **dwa moduły STAIR**: regulacja afektu (8 sesji) i kompetencje interpersonalne (8 sesji). W sekcji 02 — **NST** — stopniowe przetwarzanie narracyjne. Sekcja 03 — **twoja gotowość** + plan pracy. Sekcja 04 — pytania do specjalisty.

DLACZEGO TO DZIAŁA

STAIR (*Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation*; Cloitre, Cohen & Koenen, 2006, 2010) to **najlepiej zewalutowany protokół Fazy 1** dla C-PTSD. 8–16 sesji w strukturze modułowej: regulacja afektu, kompetencje interpersonalne. **Cloitre i in. (2012, RCT, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*):** STAIR + NST *skuteczniejsza* niż sama terapia ekspozycyjna dla C-PTSD związanego z traumą dziecięcą — $d = 1,05$ kontra $d = 0,82$. Niższy wskaźnik porzucenia terapii niż protokoły bez Fazy 1. **Kluczowa zasada Cloitre:** bez stabilnych umiejętności regulacyjnych narracja traumy jest *ponownym odtworzeniem* (ang. *reenactment*), nie przetwarzaniem. Stąd: *najpierw umiejętności, potem narracja*. STAIR (Faza 1) — 8 sesji treningu umiejętności: (a) *regulacja emocji* — identyfikacja, tolerancja, modulacja (rozpoznawanie emocji, „pęknięcia” intensywności, strategie obniżania); (b) *regulacja interpersonalna* — asertywność, praca z relacjami, granice; (c) *praca z wyzwaczami* — identyfikacja schematu aktywacji. NST (*Narrative Story Telling*, Faza 2) — 8 sesji narracyjnych: *stopniowe* pisanie i omawianie historii traumy z terapeutą, zaczynając od *bezpieczniejszych* epizodów. To *nie* jest klasyczna ekspozycja typu „prolonged exposure” Foa — to *strukturalne* przetwarzanie z bezpiecznymi marginesami. **Wskazania szczególne:** C-PTSD z traumą dziecięcą, przemoc domowa (DV), handel ludźmi — gdy dysfunkcja relacyjna jest wyraźna. **Przeciwwskazania względne:** aktywne ryzyko suicydalne, ostre uzależnienie — wymaga najpierw stabilizacji. Cloitre i in. (2010, manual STAIR — dostępny dla klinicystów). Klientka z C-PTSD od dzieciństwa: terapeuta specjalizujący się w PE proponuje natychmiastowe przetwarzanie traumy bez Fazy 1. W 4. sesji klientka destabilizuje się, samookalecza, kryzys. Bez kompetencji regulacji afektu *nie ma narzędzi*, by tolerować ekspozycję. STAIR wprowadzony *przed* PE/CPT/EMDR daje pacjentowi: okno tolerancji, regulację emocji, asertywność, granice — narzędzia do bezpiecznego przejścia w Fazę 2.

01 STAIR — dwa moduły, 8–16 sesji

MODUŁ 1 · REGULACJA AFEKTU (SESJE 1–8)

Rozpoznawanie emocji (mapowanie afektu w ciele, nazywanie). **Tolerancja** (techniki *grounding*, oddech wago-toniczny, okno tolerancji). **Modulacja** (strategie obniżania intensywności, planowanie aktywności regulujących).

Cel: pacjent potrafi rozpoznać, tolerować i modulować emocje *samodzielnie*, bez sięgania po destrukcyjne mechanizmy.

MODUŁ 2 · INTERPERSONALNE (SESJE 9–16)

Asertywność (DEAR MAN, wyrażanie potrzeb, prośby). **Praca z relacjami** (rozpoznanie schematów, komunikacja). **Granice** (rodzaje, praktyka, balans).

Cel: pacjent ma kompetencje do bezpiecznych relacji — może wyrażać potrzeby, stawiać granice, rozwiązywać konflikty bez przemocy lub wycofania.

02 NST — stopniowe przetwarzanie narracyjne

Narrative Story Telling — 8 sesji narracyjnych *po* STAIR. **Kluczowa zasada Cloitre:** bez stabilnych umiejętności regulacyjnych narracja traumy jest *ponownym odtworzeniem* (ang. *reenactment*), nie przetwarzaniem. Stąd: *najpierw umiejętności* (STAIR), *potem* narracja (NST).

Pacjent pisze i omawia historię traumy z terapeutą, zaczynając od *bezpieczniejszych* epizodów (mniej intensywnych, lepiej zintegrowanych). Stopniowe zwiększanie intensywności w miarę, jak umiejętności regulacyjne są coraz mocniejsze. To *nie* jest klasyczna ekspozycja typu „prolonged exposure” — to *strukturalne* przetwarzanie z bezpiecznymi marginesami: każda sesja kończy się *integracją* (refleksja, połączenie z teraźniejszością, plan na tydzień).

Cloitre i in. (2012, RCT): STAIR + NST $d = 1,05$ wobec $d = 0,82$ dla samej PE w C-PTSD z traumą dziecięcą. Niższy wskaźnik porzucenia terapii.

03 Moja gotowość + pytania do specjalisty

KTÓRE UMIEJĘTNOŚCI JUŻ MAM

— rozpoznawanie emocji / regulacja oddechem / grounding / asertywność / granice; jakie konkretnie

CZEGO MI BRAKUJE — LUKA DO UZUPEŁNIENIA W STAIR

— co najtrudniej, co chciałbym/-łabym wzmocnić w pierwszym module

PYTANIA DO SPECJALISTY STAIR

— „czy znasz manual Cloitre 2010?”, „czy planujesz NST po STAIR?”, „ile sesji na moduł?”

MÓJ PLAN DALSZEJ DROGI PO STAIR

— NST? EMDR? IFS? Schema? wszystko zależy od stabilności po STAIR

Klucz: STAIR jest **najlepiej zewalutowanym** protokołem Fazy 1 dla C-PTSD — Cloitre i in. (2012, RCT) pokazali skuteczność *większą* niż sama ekspozycja, z *niższym* wskaźnikiem porzucenia. To kluczowe: protokoły, które klient kończy, działają. Protokoły, które klient przerywa, *nie* działają (a często szkodzą). STAIR ma *strukturę* i *cele* — to *nie* jest „rozmawianie o uczuciach” przez 16 sesji. To *trenowane* umiejętności, z manuałem, zadaniami domowymi, miernikami postępu. Specjalista bez znajomości manuala Cloitre często „*robi STAIR*” tylko z nazwy, bez struktury — wtedy efekty są nieprzewidywalne. Pytanie kontrolne: „czy korzystasz z manuala Cloitre 2010?” — to ważny filtr.

△ STAIR jest protokołem ustrukturyzowanym — wymaga zaangażowania w zadaniach domowych, ćwiczeniach, śledzeniu postępu. Nie pasuje do każdego pacjenta. Dla pacjentów z silną dysocjacją strukturalną, aktywnym ryzykiem suicydalnym, ostrym uzależnieniem — *najpierw inna stabilizacja, potem ewentualnie STAIR*. Dla pacjentów nie zorientowanych na strukturę warto rozważyć Schema Therapy lub IFS jako alternatywy.